# 발달 트라우마 (Developmental Trauma)

학습용 정리 자료 · What(개념) – Why(원인) – How(치료) – 일반 트라우마와의 차이

> **한 줄 요약** — 발달 트라우마는 생존을 의존해야 하는 양육자로부터, 신경계와 자기가 형성되는 시기에, 만성적·반복적으로 경험한 관계 외상이다. 그 결과는 특정 기억의 문제가 아니라 **조절·자기·관계 체계 전반의 발달적 손상**으로 나타난다.

## 1. What — 개념

### 1-1. 정의

아동·청소년기의 발달 과정에서 주 양육자와의 관계 안에서 지속적·반복적으로 경험한 **만성적 대인관계 외상**을 말한다.

- **대표 유형:** 방임, 정서적·신체적·성적 학대, 가정폭력 목격, 양육자의 심각한 정신질환·중독으로 인한 예측 불가능한 양육, 반복적 분리·상실
- **핵심 특징:** ① 발달 결정적 시기에 ② 관계 안에서 ③ 반복적으로 일어나며 ④ 도망칠 수 없는 구조(가해자 = 보호자)

### 1-2. 개념의 등장과 진단적 위치

- 반 데어 콜크(B. van der Kolk)와 미국 국립아동외상스트레스네트워크(NCTSN) 연구진이 PTSD 진단이 아동의 복합 외상을 충분히 설명하지 못한다는 문제의식에서 **발달외상장애(DTD)**를 제안했다(2005, DSM-5 포함 제안 2009).
- **DTD는 DSM-5 / DSM-5-TR에 공식 진단으로 채택되지 않았다.** 현재는 연구·임상 개념으로 사용된다.
- 공식 진단 체계에서 가장 가까운 개념은 **ICD-11의 복합 PTSD(CPTSD, 2019)**로, PTSD 증상에 정서 조절 곤란·부정적 자기개념·관계 곤란(자기조직화 장애, DSO)을 더한 구조다.

### 1-3. 4대 핵심 증상 영역

| 영역 | 주요 양상 |
|---|---|
| **정서·생리 조절 부전** | 만성 과각성(분노 폭발, 공황)과 저각성(해리, 무감각, 멍함) 사이를 오감 · 신체 감각과 감정을 알아차리고 이름 붙이는 능력 저하(실감정증 경향) |
| **주의·행동 조절 부전** | 위협 단서에 주의가 쏠려 학업·과제 집중 곤란(ADHD로 오인되기 쉬움) · 자해, 섭식 문제, 충동적 위험 행동 등 원시적 자기 진정 시도 |
| **자기·정체성 손상** | 깊은 수치심, 무가치감, “나는 근본적으로 망가졌다”는 자기상 · 경계 설정 곤란, 거절 민감성 |
| **관계·애착 손상** | 혼란형 애착 — 다가가고 싶으면서 동시에 도망치고 싶은 역설 · 친밀감이 생길 때 오히려 위협을 느끼고 관계를 밀어냄 · 피해–가해 관계의 재연 |

## 2. Why — 원인과 발생 기제

### 2-1. 왜 '발달기 + 양육자'가 결정적인가

- **해결할 수 없는 역설:** 아동에게 양육자는 안전의 원천이자 동시에 위협의 원천이다. 위협을 피해 달아날 대상(양육자)에게 달려가야 하는 구조이므로 투쟁·도피가 불가능해지고, **얼어붙음(freeze)·붕괴(collapse)·해리**가 주된 생존 전략이 된다.
- **조절 기능의 외주:** 영유아는 스스로 각성을 조절하지 못하고 양육자의 반응을 통해 진정을 배운다(공동조절 → 자기조절). 양육자가 위협이 되면 이 학습 경로 자체가 끊긴다.
- **형성 중인 구조에 새겨짐:** 성인 외상이 '완성된 구조의 손상'이라면, 발달 트라우마는 '구조가 세워지는 방식 자체의 변형'이다. 위협 환경에 맞춘 적응이 성격과 신경계의 기본값이 된다.

### 2-2. 신경생물학적 기제

#### (1) 편도체 — 위협 경보 장치

편도체는 위협 단서를 1차로 감지하고, 사건에 정서적 강도를 입혀 기억을 각인하며, 시상하부를 통해 HPA 축(시상하부–뇌하수체–부신)을 가동해 아드레날린·코르티솔 반응을 일으킨다. 르두(J. LeDoux)는 감각 정보가 두 경로로 처리된다고 설명했다.

> **빠른 길(Low road):** 감각 자극 → 시상 → 편도체 · 정확성보다 속도, 생각하기 전에 몸이 반응
> **느린 길(High road):** 감각 자극 → 시상 → 대뇌피질·전전두엽 → 편도체 · 맥락 분석 후 "위험 아님"이면 경보를 끔

만성적 위협 환경에서 자란 뇌는 경보 감도를 높게 설정한다. 그 결과 무표정, 침묵, 한숨, 말투 변화 같은 중립 신호를 위협·거절로 해석하는 **오경보**가 일상화된다.

#### (2) 내측 전전두엽(mPFC) — 조절 브레이크 약화

맥락 판단과 충동 억제를 담당하는 하향 조절 기능이 약해져, 경보가 울리면 상위 인지가 이를 끄지 못하고 생존 반응이 행동을 장악한다.

#### (3) 해마 — 기억의 맥락화 곤란

만성 스트레스 호르몬 노출은 해마 기능에 영향을 주며, 기억에 '언제·어디서'라는 맥락이 붙지 않아 과거의 공포가 '지금 일어나는 일'처럼 재경험될 수 있다.

#### (4) 자율신경계 — 인내의 창(Window of Tolerance) 축소

각성을 감당할 수 있는 범위(D. Siegel)가 좁아져, 작은 자극에도 과각성(투쟁·분노) 또는 저각성(해리·붕괴)으로 쉽게 이탈한다. 다미주신경 이론(S. Porges)은 이를 타인과의 연결을 통해 진정하는 사회적 관여 체계가 충분히 발달하지 못한 상태로 설명한다.

### 2-3. 결과로서의 행동: '증상'이 아니라 '적응'

| 겉으로 보이는 행동 | 기저의 생존 기능 |
|---|---|
| **분노 폭발, 반항** | 투쟁 반응 — 위협에 먼저 공격해 통제감 확보 |
| **멍함, 무반응** | 얼어붙음·해리 — 감당할 수 없는 각성으로부터 차단 |
| **초경계** | 위험 예측 — 양육자의 기분을 미리 읽어야 했던 환경의 산물 |
| **관계 밀어내기** | 친밀감 = 위험이라는 학습 — 버려지기 전에 먼저 끊음 |
| **자해·위험 행동** | 조절 수단 부재 — 고통을 즉각 낮추는 원시적 자기 진정 |

## 3. How — 치료와 개입

### 3-1. 핵심 원칙

- **안전이 먼저:** 신경계는 '안전'을 말로 배우지 않는다. 경보가 울리는 상태에서는 인지적 설득이나 위로가 흡수되지 않는다.
- **상향식(Bottom-up) → 하향식(Top-down):** 호흡, 그라운딩, 감각 자각 등으로 각성을 먼저 조절한 뒤, 의미 탐색·인지적 처리로 나아간다.
- **관계가 곧 개입:** 일관되고 예측 가능한 상담 관계 자체가 교정적 정서 경험이자 공동조절의 경험이 된다. 시간 엄수, 예고 없는 변화 최소화, 파열 후 회복(rupture–repair)이 중요하다.
- **행동이 아닌 기능을 본다:** "무엇이 문제인가"보다 "이 행동은 무엇으로부터 이 아이를 지켜 왔는가"를 묻는다.

### 3-2. 단계적 치료 모델 (Herman, 1992)

| 단계 | 목표 | 주요 작업 |
|---|---|---|
| **1단계**<br>**안전·안정화** | 각성 조절, 일상 안정, 치료 동맹 | 심리교육("네 뇌는 고장 난 게 아니라 적응한 것"), 인내의 창 확장, 그라운딩·호흡, 감정 명명, 생활 환경 안전 점검 |
| **2단계**<br>**외상 기억 처리** | 기억을 감당 가능한 방식으로 통합 | 창 안에서 조금씩 다루기(적정, titration), 외상 내러티브, EMDR 등 — **1단계가 충분할 때만** 진입 |
| **3단계**<br>**통합·재연결** | 새로운 자기상과 관계 형성 | 정체성 재구성, 건강한 관계 경험, 미래 계획, 공동체 연결 |

※ 발달 트라우마에서는 1단계에 가장 많은 시간이 소요되며, 단계는 직선이 아니라 필요에 따라 오가는 순환 구조다.

### 3-3. 대표적 치료 접근

| 접근 | 특징 |
|---|---|
| **ARC (애착·조절·역량)** | 복합 외상 아동·청소년을 위한 틀. 양육자 정서 조절과 애착 강화 → 아동의 자기조절 → 역량·정체성 순으로 구성. 기관·가정 현장 적용이 쉬움 |
| **TF-CBT** | 외상 초점 인지행동치료. 심리교육·이완·정서조절·인지대처·외상 내러티브·보호자 참여. 아동 외상 치료에서 근거가 가장 풍부 |
| **CPP / PCIT** | 부모–자녀 관계 기반 치료. CPP는 0–5세 애착 중심, PCIT는 부모–아동 상호작용 코칭 |
| **EMDR** | 양측성 자극을 활용한 외상 기억 처리. 복합 외상에서는 안정화 단계를 길게 둠 |
| **신체 기반 접근 (SE, 감각운동 심리치료)** | 신체 감각과 움직임을 통해 미완결된 방어 반응을 완결하고 각성을 조절 |
| **NMT (신경순차 모델, B. Perry)** | 뇌 발달 순서(뇌간 → 변연계 → 피질)에 맞춰 리듬·감각 활동부터 관계·인지 개입 순으로 배치 |
| **DBT-A** | 청소년 변증법적 행동치료. 자해·충동성이 두드러질 때 정서조절·고통감내 기술 훈련 |

### 3-4. 임상 체크포인트

- **감별 진단:** 품행장애, 적대적 반항장애(ODD), ADHD, 양극성 장애로 보이는 증상이 기저의 외상 반응은 아닌지 확인한다. 외상 이력 탐색을 평가에 포함한다.
- **경보가 울릴 때:** 설득·훈계보다 목소리 톤 낮추기, 속도 늦추기, 선택권 주기, 감각 그라운딩으로 각성을 먼저 낮춘다.
- **환경 개입:** 외상이 진행 중인 환경에서는 개인 치료만으로 한계가 있다. 보호 체계·학교·보호자와의 연계가 치료의 일부다.
- **상담자 자기돌봄:** 관계 밀어내기와 시험 행동은 상담자를 소진시킨다. 수퍼비전과 대리 외상 관리가 필수다.

## 4. 일반 트라우마(PTSD)와의 차이

### 4-1. 핵심 비교

| 구분 | 일반 트라우마 (단일 사건 PTSD) | 발달 트라우마 (복합 외상) |
|---|---|---|
| **발생 시기** | 생애 전 주기, 주로 성격 구조가 형성된 이후 | 영유아기~청소년기, 발달 결정적 시기 |
| **외상의 성격** | 단발성·돌발적 사건(재난, 사고, 폭행) | 만성적·반복적 관계 외상(학대, 방임, 가정폭력) |
| **가해·환경** | 외부 환경, 낯선 사람 | 생존을 의존해야 하는 주 양육자 |
| **손상의 대상** | '무엇이 일어났는가' — 특정 기억 | '나는 누구인가' — 자기·조절·관계 체계 |
| **주요 증상** | 침습(플래시백), 회피, 과각성, 인지·기분의 부정적 변화 | 정서·행동 조절 부전, 해리, 수치심·무가치감, 혼란형 애착 |
| **외상 이전** | 돌아갈 '이전의 자기'가 존재 | 돌아갈 안전한 기준점이 없음 |
| **흔한 오인** | 비교적 명확하게 진단됨 | ADHD, ODD, 품행장애, 양극성 장애 등으로 오인되기 쉬움 |
| **치료 초점** | 외상 기억 처리(지속노출, CPT, EMDR 등)가 비교적 빠르게 가능 | 장기간의 안정화·관계 회복이 선행, 기억 처리는 그 이후 |
| **치료 목표** | 회복(recovery) — 이전 기능으로 복귀 | 형성(formation) — 처음으로 안전과 조절을 획득 |